

Comorbidités monotropes : vérification du cadre à quatre clusters

Un brief de recherche cité — vérifiant un cadre largement partagé des « comorbidités monotropes ».

Informationnel, non un avis médical. *Le monotropisme est un style cognitif, pas un diagnostic ; il n'a pas de « comorbidités » au sens de maladie. Ce brief évalue ce que les recoupements avec le cadre ci-dessous sont et ne sont pas soutenus comme. Il complète le brief paysager plus complet du projet, « Le monotropisme et sa toile de comorbidité ».*

Synthèse

- **L'ouverture du cadre est exactement juste : le monotropisme n'a pas de « comorbidités » au sens de maladie.** C'est un style attentionnel sur un spectre ; les recoupements avec des conditions cliniques sont des *associations et des mécanismes partagés*, pas des séquelles d'une maladie [1].
- **Une affirmation phare est à l'envers.** « *Les personnes AuDHD obtiennent les scores les plus élevés de tous les groupes au MQ* » n'est **pas** ce que montrent les données. Dans l'étude de validation du MQ, l'autisme et le TDAH augmentent chacun les scores de monotropisme, mais leur effet *combiné* est une **interaction négative** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$) : les autistes-avec-TDAH obtiennent des scores **inférieurs à ce qu'un modèle purement additif prédirait**, pas supérieurs [2].
- **Deux termes sont correctement attribués mais nécessitent des définitions précises.** La « *scission monotrope* » (*monotropic split*) est effectivement forgé par l'avocate autistique **Tanya Adkin** — mais il

signifie le coût cognitif de *forcer un esprit monotrope à fonctionner de manière polytrope* (diviser l'attention), **pas** les « tunnels AuDHD concurrents » avec lesquels on le confond parfois [3].

- **Les « problèmes de permanence de l'objet » sont contestés, pas établis.** La seule source académique (Lawson & Dombroski, 2017) propose une permanence de l'objet **retardée** comme *hypothèse* pour certains stress liés à l'autisme — et la littérature plus large trouve que la permanence de l'objet est typiquement *intacte ou supérieure* dans l'autisme. L'expérience « hors de vue, hors de l'esprit » se lit mieux comme un effet de **mémoire de travail / allocation de l'attention** [4].
- **Le reste est largement soutenu mais gradué par les données.** L'autisme (fondateur), l'hyperfocale du TDAH (réel), le recoupement anxiété/rumination et TOC (robuste), l'inertie autistique (réelle), le débordement sensoriel → meltdown/shutdown (réel), et le burnout par transitions forcées + masquage (construit établi) survivent tous à l'examen — l'hyper-systématisation étant la **théorie E-S distincte de Baron-Cohen**, pas une donnée du monotropisme [5].
- **Un recadrage neuroaffirmant :** chaque recoupement se better énonce comme « *la façon dont un système d'attention étroit et intense interagit avec un monde polytrope* » plutôt que comme une liste de troubles qu'un cerveau monotrope « cause ».

1. Le principe central (le cadre a ça juste)

Le monotropisme (Murray, Lawson & Lesser, 2005) pose que les esprits diffèrent dans *la façon dont ils allouent l'attention* : un esprit monotrope concentre les ressources dans quelques « tunnels d'attention » intensément activés ; un esprit polytrope les répartit sur de nombreux canaux [1]. Parce que c'est un **style cognitif dimensionnel** — mesurable sur le Monotropism Questionnaire (MQ) sur une échelle 1–5 — il n'a pas de « comorbidités ». Ce qu'il a, ce sont des **associations statistiques** (des groupes qui obtiennent des scores plus élevés) et des **mécanismes partagés** (des conditions dont les caractéristiques sont aidées à expliquer par une lentille d'allocation de l'attention). Maintenir cette distinction est tout l'enjeu [1][2].

Ce brief est organisé comme une **vérification assertion par assertion** du cadre à quatre clusters, graduant chaque élément. Il complète (ne répète pas) le brief paysager existant du projet, qui couvre les troubles du comportement alimentaire, l'accumulation, l'agoraphobie, l'évitement de la demande et le problème de la double empathie plus en profondeur.

2. Cluster 1 — Profils neurodivergents centraux

Autisme (fondateur, lien le plus fort)

Le monotropisme fut *créé* pour expliquer les traits autistiques — intérêts spéciaux intenses, besoin de routine (qui protège le tunnel d'attention), et différences dans l'interaction sociale [1]. Le MQ le confirme empiriquement : les participants autistes obtenaient en moyenne **4,15/5** vs **3,19/5** pour les non-autistes (n=1 110) [2]. C'est le terrain de la théorie et le lien le mieux documenté.

TDAH (réel et mesuré)

Le TDAH augmente significativement les scores de monotropisme ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. Le lien est conceptuel autant que statistique : l'**hyperfocale** du TDAH (Grotewiel et al., 2022, sur l'hyperfocale comme construit distinct) est quasi identique au tunnel monotrope, et la « dysfonction exécutive » d'activation de l'attention pour des tâches non-intéressantes est une prédiction naturelle d'un système tunnelisé [2][6]. **Soutenu.**

AuDHD (l'affirmation phare est à l'envers) — *la correction clé*

Assertion vérifiée : « Les personnes avec un profil AuDHD combiné obtiennent les scores les plus élevés de tous les groupes au MQ. »

Ce **n'est pas** ce que montrent les données. La régression multiple du papier MQ a régressé le monotropisme sur le statut TDAH, le statut autisme, et leur **interaction** [2] :

Prédicteur (vs aucune des conditions)	β	p
TDAH, non autiste	+0,55	<,001
Autiste, non TDAH	+1,04	<,001

Prédicteur (vs aucune des conditions)	β	p
Interaction Autisme $\times$ TDAH	-0,43	<,001

Le terme d'interaction est **négatif et significatif**. Les auteurs l'énoncent clairement : « *les scores de monotropisme ne sont pas aussi élevés pour les individus autistes avec TDAH qu'on s'y attendrait sur la base d'effets purement additifs* » [2]. Autrement dit, ajouter le TDAH à l'autisme ne pousse **pas** le monotropisme plus haut que ce que l'autisme seul prédirait — il arrive **plus bas** que la somme des deux effets indépendants.

- Le **groupe unique au score le plus élevé** est les autistes (4,15) ; le fait que la *moyenne de cellule* empirique pour autiste-avec-TDAH soit juste au-dessus ou en dessous dépend de la combinaison exacte, mais l'affirmation du cadre que AuDHD est « *le plus élevé de tous* » comme effet additif/super-additif est **non soutenue et contredite par l'interaction**.
- L'image *intuitive* que le cadre offre — « une traction interne entre le besoin autistique d'un tunnel stable et profond et la pulsion TDAH vers un input nouveau » — est une description populaire et phénoménologiquement résonnante de l'expérience AuDHD, mais c'est un **récit clinique/communautaire, pas une donnée de score au MQ**. Énoncez-le comme expérience vécue, pas comme un résultat du MQ [6].

Énoncé corrigé : « *L'autisme et le TDAH augmentent chacun indépendamment les scores de monotropisme, mais les deux interagissent de manière non additive : les autistes avec TDAH obtiennent un score plus bas au MQ qu'un modèle purement additif ne le prédirait — suggérant que les deux conditions ne s'« empilent » pas simplement sur la tendance monotrope.* » [2]

3. Cluster 2 — Traits cognitifs & de santé mentale

Anxiété et rumination ✓ (association robuste, mécanisme plausible)

L'anxiété et la rumination sont élevées dans la population autiste/TDAH, et le cadre du monotropisme offre un mécanisme propre : un esprit tunnelisé qui s'accroche à une souci la traite en boucle (« rumination »), rendant l'anxiété « collante » [7][8]. La structure à 8 facteurs du MQ inclut même une sous-échelle « **rumination et anxiété** », montrant que le cluster est empiriquement serré [2]. **Soutenu** — notez cependant que la flèche causale (le monotropisme *produit-il* l'anxiété, ou partage-t-il un substrat avec elle ?) n'est pas établie.

TOC ✓ (recoupement robuste, distinction importante)

Le recoupement autisme–TOC est réel et répliqué. Une méta-analyse trouve qu'environ **~17 % des autistes remplissent les critères de TOC** (vs ~1–2 % dans la population générale) ; l'inverse est aussi élevé [9]. La distinction qualitative que trace le cadre est exactement juste et bien articulée : **les intérêts monotropes sont ego-syntones** (pilotés par la fascination/la joie), tandis que **les compulsions du TOC sont ego-dystones** (pilotées par la détresse et accomplies pour neutraliser la peur) [10]. Cette distinction est cliniquement importante car les deux peuvent autrement être difficiles à distinguer en pratique. **Soutenu.**

Hyper-systématisation ⚠ (construit réel, mais c'est celui de Baron-Cohen, pas une donnée du monotropisme)

L'« hyper-systématisation » — la pulsion d'analyser, construire et explorer des systèmes — est un trait autistique authentique et bien étudié, mais il appartient à la **théorie Empathizing–Systemizing (E-S)** de Simon Baron-Cohen, pas au monotropisme [5]. Les deux théories se recoupent fortement (toutes deux décrivent un style cognitif intense et centré sur le détail) et sont parfois confondues, mais ce sont des **cadres distincts** avec des mesures distinctes (le quotient EQ/SQ vs le MQ). Le mouvement honnête : présentez l'hyper-systématisation comme *cohérente avec* un style monotrope (un esprit tunnelisé est bien adapté pour maîtriser des systèmes) tout en créditant la théorie E-S comme son propre truc [1][5].

4. Cluster 3 — Phénomènes neurologiques & de traitement

Problèmes de permanence de l'objet **✗** (contesté — la seconde correction clé)

Assertion vérifiée : « Les individus monotropes expérimentent la permanence de l'objet différemment... le cerveau arrête effectivement d'en traiter l'existence jusqu'à ce que quelque chose l'en tire de l'extérieur. »

C'est l'affirmation la **plus faible** du cadre et demande une manipulation soigneuse :

- Il y a **une** source académique proposant un lien de permanence de l'objet : **Lawson & Dombroski (2017)**, qui fait l'hypothèse qu'une permanence de l'objet **retardée** pourrait contribuer à certains stress et anxiétés liés à l'autisme [4]. Note : c'est un article de construction d'hypothèse, pas une étude de confirmation.
- La littérature développementale plus large trouve que la **permanence de l'objet de base est typiquement intacte ou supérieure dans l'autisme** ; les tâches piagétienne de permanence de l'objet sont généralement réussies aux âges typiques [4].
- Le phénomène *réel* que le cadre cherche — « hors de vue, hors de l'esprit » pour les tâches, objets et même personnes — s'explique mieux comme un effet de **mémoire de travail / allocation de l'attention** : un esprit tunnelisé ne *manque* pas de représenter l'objet, il **manque de réorienter l'attention vers lui**. C'est le monotropisme qui fonctionne comme prédit (un système tunnelisé a peu de ressources libres pour la réorientation périphérique), pas un déficit de permanence de l'objet [1][4].

Énoncé corrigé : « L'expérience 'hors de vue, hors de l'esprit' chez les personnes fortement monotropes se comprend mieux comme un effet d'allocation de l'attention / de mémoire de travail — l'esprit représente l'objet mais ne se réoriente pas vers lui pendant qu'il est tunnelisé — plutôt qu'un déficit de permanence de l'objet (qui est typiquement intact dans l'autisme). » [1][4]

Dysrégulation sensorielle / débordement ✓ (mécanisme bien soutenu)

C'est fortement soutenu. Parce qu'un système tunnelisé dépense ses ressources centralement, un input sensoriel intrusif soudain (sirène, lumière, toucher) exige une réallocation coûteuse — vécue comme une « perturbation violente ». Cela s'aligne avec la littérature établie sur l'hyper-réactivité sensorielle et la voie bien documentée de la surcharge sensorielle au **meltdown** (externalisant) et au **shutdown** (retrait internalisant), tous deux reconnus comme réponses de débordement involontaires [7][11]. Le cadre du monotropisme ajoute un *mécanisme* (coût de réallocation) à ce qui est autrement une donnée descriptive. **Soutenu.**

Inertie autistique ✓ (réel, de plus en plus étudié)

La « difficulté profonde avec les transitions — mal à commencer, arrêter ou changer de cap » est le construit établi de **l'inertie autistique** : difficulté avec l'initiation/terminaison/bascule de tâche « pas sous contrôle conscient », d'abord articulée dans des récits communautaires autistes et désormais dans des travaux évalués par les pairs [12][13]. C'est conceptuellement le visage *comportemental* du « coût de bascule » que capture le facteur environnement-et-tunnel du MQ [2]. **Soutenu** — et c'est le terme technique correct (voir le brief compagnon sur le scoring/l'inertie).

5. Cluster 4 — Résultats de stress chronique

Scission monotrope ⚠ (correctement attribuée à Adkin, mais deux sens sont confondus)

Assertion vérifiée : « La scission monotrope, forgée par la praticienne Tanya Adkin, se produit quand un esprit monotrope est forcé par son environnement de diviser son canal à focus unique à travers de multiples flux concurrents. »

L'attribution est correcte : l'avocate autistique **Tanya Adkin** a effectivement forgé « monotropic split », confirmé par de multiples sources communautaires indépendantes [3]. Et la définition du cadre ici

est **proche du sens réel d'Adkin** — le coût cognitif/le burnout qui survient quand un esprit monotrope est *forcé de « performer polytrope »* ou de diviser son attention à travers des flux concurrents [3][14].

Deux mises en garde :

1. **C'est un concept communautaire/praticien, pas un construit empiriquement validé.** « Monotropic split » apparaît dans les écrits de la communauté autiste et cliniciens (p. ex. via Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) mais n'a **pas d'étude de validation évaluée par les pairs** derrière lui [3]. Traitez-le comme une *description* puissante, valide par l'expérience vécue, pas comme une entité mesurée.
2. **Deux choses différentes voyagent sous le nom.** Le sens d'Adkin = *performance polytrope forcée par un esprit monotrope* (un problème d'adéquation environnementale). Un second sens — utilisé dans certains écrits AuDHD — = la *compétition interne entre un besoin autistique de tunnel stable et une pulsion TDAH de nouveauté* (un problème de dynamique interne). Le cadre ici décrit le **premier** sens (environnemental). Ils sont liés mais distincts ; les fusionner brouille le concept. (Le brief paysager du projet utilise « monotropic split » dans le second sens AuDHD — le terme est donc authentiquement surchargé dans le champ.) [3][6]

Énoncez-le comme : « Le terme 'monotropic split' de l'avocate autistique Tanya Adkin décrit le coût cognitif et le burnout qui surviennent quand un esprit monotrope est forcé de fonctionner de manière polytrope — un puissant concept communautaire qui attend une validation formelle. » [3]

Burnout  (construit établi ; le lien au monotropisme est heuristique)

Le burnout autistique est désormais un construit bien défini : **épuisement chronique, perte de compétences et tolérance réduite au stimulus**, conceptualisé comme résultant d'un stress de vie chronique et « d'une inadéquation des attentes et des capacités » sans soutien et récupération adéquats (Raymaker et al., 2020 ; Higgins et al., 2021, une étude Grounded-Delphi avec des experts autistes) [15][16]. Le chemin du monotropisme vers le burnout — transitions forcées constantes,

masquage et « scission monotrope » drainant les ressources sans temps de récupération/flux — est **heuristiquement puissant et validé par la communauté**, mais la contribution *spécifique* de la rupture de tunnel au burnout (versus masquage, traumatisme, charge sensorielle, demande chronique) **n'a pas été isolée expérimentalement** [15]. **Soutenu comme hypothèse forte, pas comme chaîne causale établie.**

6. Un tableau de bord gradué

Affirmation du cadre	Verdict	Note
Le monotropisme n'a pas de comorbidités-maladie	✓ Correct	Il a des associations + des mécanismes partagés [1]
Autisme = lien primaire	✓ Fondateur	MQ 4,15 vs 3,19 [2]
Le TDAH augmente le monotropisme	✓ Soutenu	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD obtient le score le plus élevé de tous	✗ À l'envers	L'interaction est négative ($\beta = -0,43$) [2]
Recoupement anxiété & rumination	✓ Robuste	Le MQ a un facteur rumination/anxiété [2]
Recoupement TOC (ego-syntone vs dystone)	✓ Soutenu	~17 % de co-occurrence ; distinction correcte [9][10]
Hyper-systématisation	⚠ Réel mais mal étiqueté	C'est la théorie E-S de Baron-Cohen, pas le monotropisme [5]
Problèmes de permanence de l'objet	✗ Contesté	1 papier d'hypothèse ; PO typiquement intacte ; c'est l'allocation de l'attention [4]
Débordement sensoriel → meltdown/shutdown	✓ Bien soutenu	Mécanisme = coût de réallocation [7][11]
Inertie autistique	✓ Réel	Terme correct ; évalué par les pairs [12][13]
Scission monotrope forgée par Adkin	⚠ Attribution juste ; communautaire, non validé	Deux sens confondus [3]
Burnout par transitions forcées + masquage	✓ Construit établi ; lien heuristique	Non isolé expérimentalement [15][16]

7. Enseignements pratiques

- **Ouvrez avec le principe** : le monotropisme est un style attentionnel mesurable dont les *recoupements* avec des conditions sont des associations et des mécanismes partagés — jamais « il cause X ». [1]
 - **Citez le MQ correctement** : l'autisme et le TDAH augmentent chacun les scores, mais la combinaison est **non additive (inférieure à l'attendu)** — ne dites pas AuDHD obtient le score le plus élevé [2].
 - **Gardez la distinction ego-syntone/ego-dystone** en discutant TOC vs intérêts spéciaux — c'est cliniquement utile et correctement cadré [10].
 - **Créditez les cadres précisément** : l'hyper-systématisation = théorie E-S de Baron-Cohen ; la scission monotrope = concept communautaire d'Adkin (sens de la polytropie forcée environnementale) ; l'inertie autistique = le construit évalué par les pairs de difficulté de transition [3][5][12].
 - **Abandonnez « le déficit de permanence de l'objet »** : recadrez comme allocation de l'attention / mémoire de travail, ce qui est à la fois précis et plus utile pour le soutien [1][4].
 - **Distinguez validé vs heuristique** : le burnout est un construit établi, mais le chemin monotropisme→burnout est une hypothèse forte, pas un effet mesuré ; « la scission monotrope » est valide par l'expérience vécue mais non validée [3][15].
-

Sources

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.

doi:10.1177/1362361305051398 — origine du monotropisme ; une différence d'allocation des ressources (un continuum), pas un déficit.

<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (auto-évaluation à 47 items ; préprint de validation). Open Science Framework. — n=1 110 ; moyenne autistes 4,15 (ET ,347) vs non-autistes 3,19 (ET ,578) ; régression $\beta(\text{TDAH})=+0,55$, $\beta(\text{autisme})=+1,04$, $\beta(\text{interaction})=-0,43$, $p<,001$; l'interaction TDAH+autisme est sous-

additive ; structure à 8 facteurs incl. facteurs rumination/anxiété & environnement/tunnel. <https://osf.io/wpx5g> · validation : <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Archive locale : [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)

[3] Adkin, T. — « monotropic split » (avocate autistique / praticienne ; concept communautaire). Confirmé via de multiples sources communautaires indépendantes : Neurodivergent Insights (glossaire), Kelly Mahler (invité), David Gray Hammond, Jade Farrington (« Quand les personnes monotropes sont forcées de fonctionner de manière polytrophe, cela s'appelle la scission monotrope »). Définition : le coût cognitif/le burnout de forcer un esprit monotrope à « performer polytrophe ». Concept communautaire/praticien — **pas d'étude de validation évaluée par les pairs**. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1). doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *fait l'hypothèse* d'une permanence de l'objet **retardée** comme contributeur à certains stress liés à l'autisme (un article de construction d'hypothèse, pas une confirmation). Littérature plus large : la permanence de l'objet est typiquement intacte/supérieure dans l'autisme ; « hors de vue, hors de l'esprit » se lit mieux comme allocation de l'attention/mémoire de travail. Archive locale : [sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) · <https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS ; APA PsycNet. — l'hyper-systématisation et la théorie E-S sont le cadre de Baron-Cohen, mesurées via le quotient EQ/SQ ; distincte du (bien que chevauchant) monotropisme. https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · revue : Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

- [6] Autistic Scholar — « *Revisiting monotropism* » (AuDHD comme tunnels concurrents/instables ; références Grotewiel et al. 2022 sur l'hyperfocale du TDAH comme construit distinct). Compte phénoménologique/communautaire, pas une donnée de score MQ. Archive locale : [sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html](#) · <https://www.autisticscholar.com/monotropism>
- [7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — hyper-réactivité sensorielle, conditionnement de contexte et la voie du débordement. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>
- [8] Oakley, B. et al. / littérature sur l'anxiété dans l'autisme — anxiété et rumination élevées dans la population autiste/TDAH (cité via le brief paysager de comorbidité du projet pour le substrat anxieux).
- [9] Meier, S. M. et al. / méta-analyses de la concordance autisme-TOC — ~17 % des autistes remplissent les critères de TOC (vs ~1–2 % population générale) ; ~17 % des enfants avec TOC montrent des symptômes autistiques légers. Résumé via Move Up ABA citant la recherche 2015 et l'aperçu The Transmitter/Spectrum. <https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · méta-analyse autisme↔TOC : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>
- [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). *"Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours* (qualitatif). PMC11497754 — la distinction ego-syntone (intérêts) vs ego-dystone (compulsions). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>
- [11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (externalisant) et shutdown (retrait internalisant) comme réponses involontaires au stress/débordement sensoriel écrasant. https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf
- [12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (préprint/qualitatif). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — difficulté à commencer, arrêter et basculer

des tâches « pas sous contrôle conscient ». Archive locale : [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>

[13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — inertie autistique : née de la communauté, désormais évaluée par les pairs ; cite Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024. <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glossaire) et *ADHD vs Autism vs OCD* (recoupement à trois voies). Ressource communauté/clinicien cadrant la scission monotrope et les recoupements.

<https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>

[15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — épuisement chronique, perte de compétences, tolérance réduite au stimulus ; par stress de vie chronique et inadéquation des attentes et capacités.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating*

#AutisticBurnout. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — définition de consensus : épuisement, retrait, problèmes de cognition, compétences de vie quotidienne réduites, augmentation des traits autistiques. <https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

Compagnon du brief paysager plus complet du projet :

[outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md](#) (qui couvre les troubles du comportement alimentaire, l'accumulation, l'agoraphobie,

l'évitement de la demande/PDA et le problème de la double empathie). Ce brief se concentre sur la vérification du cadre à quatre clusters ci-dessus et ne répète pas ce matériel.